

Інтубація трахеї

Сценарій

Ви – лікар з медицини невідкладних станів, в складі бригади екстреної медичної допомоги прибули на виклик. Робітник заводу попав під дію електричного струму декілька хвилин тому. Втратив свідомість. Мали місце судоми. Дія струму була припинена. Хворий лежить на спині, дихання відсутнє, пульс не визначається, шкіра ціанотична, зіниці широкі, на світло не реагують. Ви приступаєте до відновлення прохідності дихальних шляхів.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Приміщення, що імітує приміщення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен для інтубації трахеї	1 шт.
6	Ларингоскоп	1 шт
7	Мішок Амбу	1 шт
8	Набор для інтубації	10 шт
9	Каремат чи ковдра під манекен	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Ларингоскоп	1шт.
2	Мішок Амбу з лицьовою маскою	1 шт.



ЛАРИНГОСКОП

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановлення контакту з людьми які намагались надати допомогу (привітатись, представитися, позначити свою роль). Відповідь на питання лікаря до людей надає	<i>Сказати</i> Доброго дня. Я лікар з медицини невідкладних станів, що тут сталося?

	екзаменатор.	Скільки минуло часу з моменту як постраждалий знепритомнів? <i>Відповідь:</i> Це трапилось близько 2 хвилин назад він потрапив під дію електричного струму.
1.2	Одягнути медичні рукавички	<i>Виконати</i>
2.Виконання навички		
2.1	Розкрийте рот пальцями правої руки: перехрещені великий та вказівний пальці розташуйте на зубах (у беззубого пацієнта — на яснах) нижньої та верхньої щелеп і розкрийте рот.	<i>Виконати</i>
2.2	Утримуючи ручку ларингоскопа лівою рукою, введіть клинок ларингоскопа у ротову порожнину через правий кут рота. Слідкуйте, щоб не притискати клинком ларингоскопа губи до зубів та щоб не виламати зуби.	<i>Виконати</i>
2.3	Після досягнення кінцем клинка кореня язика (надгортанна долина), змістіть язик пацієнта клинком ларингоскопа вліво і натисніть клинком або кінцем клинка ларингоскопа на основу язика над входом до гортані (не тисніть на надгортанник), підтягуючи ларингоскоп догори. Якщо це необхідно, видаліть відсмоктувачем виділення із ротової порожнини та горла.	<i>Виконати</i>
2.4	Візуалізуйте усю голосову щілину (якщо це можливо), інтубаційну трубку, тримаючи у правій руці, введіть через правий кут рота і проведіть між голосовими зв'язками	<i>Виконати</i>
2.5	Притримуючи трубку на відповідній глибині, (зазвичай 20–22 см), вийміть ларингоскоп і попросіть асистента наповнити ущільнюючу манжету повітрям	<i>Виконати</i>
2.6	Переконайтесь у правильності розташування трубки, аускульовуючи грудну клітку хворого. Після під'єднання до трубки набору для вентиляції, напр. мішка Амбу, і початку вентиляції, повинні вислуховуватись симетричні дихальні шуми над основами обох легень (низом, боками) та над їх верхівками (під ключицями); виключте інтубацію стравоходу аускультациєю епігастрію (шлунка – шум булькотіння під час спроби вентиляції через	<i>Виконати</i>

	трубку, розміщену в стравоході) та капнометрією, якщо доступна (відсутність CO ₂ у повітрі, що виходить із трубки, встановленої в стравоході). У випадку сумнівів видаліть трубку і повторіть спробу її введення після попередньої преоксигенації.	
2.7	Зафіксуйте інтубаційну трубку відповідним фіксатором, бинтом або лейкопластиром; для попередження перекусування трубки, розмістіть між зубами рото-горлову трубку або згорнутий бинт	<i>Виконувати</i>
2.8	Зняти рукавиці.	<i>Виконати</i>
3. Встановити попередній діагноз (визначити стан пацієнта)		
3.1	Стан клінічної смерті	<i>Сказати</i>
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Після встановлення інтубаційної трубки, провести СЛР, та як найшвидше доправити до спеціалізованого закладу	<i>Сказати</i>